

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師	病院と共有する情報	病院薬剤師
- S-1・カペシタビンの服用日・休業日と残薬の管理 - 腎機能とS-1の用量、フツ化ピリミジン系の重複確認 - 電話フォローで悪心・下痢・発熱・食事を確認 - 胃切除後の食事・体重の変化を聴取し栄養指導へつなぐ - 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ	病院と共有する情報 バイオマーカー・レジメン (お薬手帳) 検査値 (腎機能・好中球数) 悪心・下痢のGrade (トレーシングレポート) 食事量・体重 (電話フォローの結果)	- HER2・CLDN18.2・PD-L1の結果とレジメンの整合性の監査 - シスプラチンの補液・Mg補充、制吐薬の設定 - ゾルベツキシマブ初回の投与速度・制吐薬強化の管理 - T-DXd・ニボルマブのILD・irAE発症時の院内連携 - お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載

2 主なレジメンと薬局での確認ポイント

SOX / CAPOX 点滴+経口	オキサリプラチン(1日目)+S-1またはカペシタビン1~14日目内服	3週毎	✓内服日数と休業 ✓寒冷刺激による急性しびれ ✓手足症候群(カペシタビン)
S-1+シスプラチン 点滴+経口	S-1 1~21日目内服+シスプラチン(8日目)	5週毎	✓シスプラチンの大量補液・腎機能 ✓高度催吐性の制吐薬
S-1単独(術後) 経口	S-1 4週服用・2週休業を1年間	6週毎	✓腎機能に応じた用量 ✓流涙・色素沈着 ✓アドヒアランス
RAM+PTX 点滴・注射	ラムシルマブ(1・15日目)+パクリタキセル(1・8・15日目)	4週毎	✓高血圧・尿蛋白 ✓好中球減少 ✓末梢神経障害
ゾルベツキシマブ併用 点滴・注射	ゾルベツキシマブ+CAPOX/SOX等	3週毎	✓初回の悪心・嘔吐(制吐薬の強化) ✓体重・食事量
T-DXd 点滴・注射	点滴(HER2陽性、化学療法後)	3週毎	✓咳・息切れ・発熱(ILD) ✓悪心・嘔吐 ✓骨髄抑制

● 経口 ● 点滴・注射 ● 点滴+経口 経口薬は保険薬局で交付:服用日・休業日と自宅での副作用を確認

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフツ化ピリミジン系(カペシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意 添付文書 併用注意	S-1・カペシタビン CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定頻度を処方医と確認
注意 添付文書 用法・用量	S-1 ギメラシルの排泄低下	既往・疾患 腎機能の低下	5-FU濃度↑ → 骨髄抑制・下痢	CCrに応じた用量を確認
注意 添付文書 用法・用量	FTD/TPI 空腹時は吸収が増加	生活習慣 空腹時の服用	好中球減少が増強	朝・夕の食後に服用するよう指導
確認 服薬指導上の注意	S-1 症状を隠す	市販薬 市販の胃腸薬・下痢止め	下痢・脱水の見逃し	市販薬の使用を聴取し、まず連絡するよう指導

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

① 治療開始前	② 投与当日~5日	③ 投与後1~2週	④ 次回来局時
“S-1は2週飲んで1週休むなど、決まった日程で飲みます。休業日もカレンダーと一緒に確認しましょう”	“吐き気止めは、吐き気がなくても決められた時間に飲んでください。水分は少しずつこまめに”	“37.5℃以上の熱や、1日4回以上の下痢が続く時は、すぐ病院へ連絡してください”	“涙が出やすい、手足がしびれる、咳や息切れが続くなどの変化はありませんか”
✓薬局で確認 お薬手帳でHER2・CLDN18.2・PD-L1、腎機能(S-1の用量)、胃切除歴	✓薬局で確認 電話フォローで悪心・水分量・尿量(シスプラチン後)を確認	✓薬局で確認 電話フォローでnadir期の発熱、S-1の下痢・口内炎を確認	✓薬局で確認 流涙・色素沈着、しびれのGrade、体重、咳・息切れ
△ここに注意 他のフツ化ピリミジン系・ワルファリンとの併用を確認	△ここに注意 水分がとれない・尿が少ない時は至急連絡	△ここに注意 発熱+悪寒、止まらない下痢は至急受診	△ここに注意 咳・息切れ・発熱はILDを疑い早めに受診